

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE APOYO SOCIAL DEL MOS (MOS-SSS)

Eje IV: Recursos y Red Social • Evaluación Multidimensional del Apoyo Social Funcional Percibido

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Apoyo Social Funcional del Medical Outcomes Study (MOS-SSS).
Nombre Original	Medical Outcomes Study Social Support Survey (MOS-SSS; Sherbourne & Stewart, 1991).
Autoras Originales	Cathy Donald Sherbourne, Ph.D. y Anita L. Stewart, Ph.D. (RAND Corporation, EE.UU.).
Adaptación Hispana	De la Revilla et al. (1991); Rodríguez-Marín et al. (1993); Bellón et al. (1996); España.
Eje Clínico y Constructo	Eje IV: Funcionamiento y Recursos. Apoyo social funcional autopercebido multidimensional.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de 19 reactivos graduados con escala Likert de 5 puntos (1 a 5) + 1 ítem de red social.
Población y Rango	Adultos (≥ 18 años) en población general, enfermos crónicos, salud mental y oncología.
Tiempo de Administración	5 a 8 minutos de autoadministración sencilla.
Régimen de Licencia	Dominio público científico (RAND Corporation) / Acceso libre sin restricciones comerciales.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL APOYO SOCIAL FUNCIONAL PERCIBIDO

El **MOS-SSS** fue desarrollado en el marco del célebre macroestudio Medical Outcomes Study (RAND Corporation) para subsanar los sesgos de los instrumentos que se limitaban a contar el número de parientes o contactos (apoyo social estructural). Sherbourne y Stewart (1991) demostraron que el factor protector verdaderamente decisivo para la salud mental no es la cantidad de personas en la agenda, sino el **apoyo social funcional percibido**: la certeza subjetiva de contar con personas accesibles cuando surge una necesidad concreta:

1. **Independencia de la Frecuencia de Contacto**: Mide la disponibilidad percibida de recursos de auxilio afectivo, tangible y lúdico en caso de requerirlos.
2. **Efecto Amortiguador del Estrés (Buffering Model)**: El apoyo social percibido actúa como un potente escudo neuroendocrino que atenúa la reactividad del eje HPA ante eventos traumáticos y pérdidas vitales.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS (19 REACTIVOS FUNCIONALES)

El instrumento explora 4 dimensiones funcionales independientes precedidas por 1 ítem sobre el tamaño de la red íntima:

Dimensión de Apoyo	Nº Ítems	Definición Operativa y Reactivos Evaluados (MOS-SSS)
1. Emocional / Informativo	8 ítems	Disponibilidad de alguien que escuche, comprenda, aconseje y brinde orientación reflexiva.
2. Instrumental / Material	4 ítems	Ayuda tangible real: llevar al médico, preparar comidas si se está enfermo, prestar auxilio físico.
3. Interacción Positiva	3 ítems	Compañía disponible para distraerse, relajarse, divertirse y compartir actividades lúdicas.
4. Apoyo Afectivo	3 ítems	Muestras explícitas de cariño físico, amor, abrazos y sentirse verdaderamente querido.
Tamaño de la Red Íntima	1 ítem	Número total de amigos íntimos y familiares cercanos con quienes se cuenta.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

La validación española de Bellón et al. (1996) y de la Revilla ($N = 393$ pacientes de atención primaria) avala su extraordinaria precisión:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Apoyo Total	Alfa $\alpha = 0.94 - 0.96$	Altísima homogeneidad interna en la puntuación global de apoyo social.
Consistencia Subescalas	Alfa $\alpha = 0.82 - 0.92$	Emocional (0.92), Instrumental (0.85), Interacción (0.88), Afectivo (0.82).
Estabilidad Test-Retest	CCI $r = 0.85 - 0.91$	Elevada estabilidad temporal a las 4 y 8 semanas en pacientes comunitarios.
Estructura Factorial	4 Factores correlacionados	Confirmación del modelo de 4 dimensiones independientes ($CFI > 0.94$).
Validez Convergente	$r = 0.65$ (Duke-UNC)	Fuerte correlación con escalas validadas de apoyo social y funcionamiento familiar.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE SUBESCALAS Y TOTAL

- **Opciones de Respuesta:** Escala Likert de 5 alternativas: Nunca (1), Pocas veces (2), Algunas veces (3), La mayoría de las veces (4), Siempre (5).
- **Cómputo por Subescalas Directas:**
 - *Apoyo Emocional / Informativo:* Suma de 8 reactivos (rango 8 a 40 puntos).
 - *Apoyo Instrumental:* Suma de 4 reactivos (rango 4 a 20 puntos).
 - *Interacción Social Positiva:* Suma de 3 reactivos (rango 3 a 15 puntos).
 - *Apoyo Afectivo:* Suma de 3 reactivos (rango 3 a 15 puntos).
- **Puntuación Total Directa:** Suma de los 19 reactivos funcionales (**rango 19 a 95 puntos**).
- **Conversión Estandarizada (0 a 100):** Para facilitar la interpretación clínica comparativa, se normaliza cada subescala a una escala porcentual de 0 a 100 puntos:

$$\text{Puntuación Normalizada (0-100)} = \left(\frac{\text{Puntuación Obtenida} - \text{Mínimo Posible}}{\text{Máximo Posible} - \text{Mínimo Posible}} \right) \times 100$$

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN DEL APOYO

Estratificación	Rango Total	Nivel de Apoyo	Significación Clínica y Pronóstico en Salud Mental
Apoyo Óptimo	80 a 95 pts	Red de apoyo excelente	Máximo efecto protector; recursos afectivos e instrumentales abundantes.
Apoyo Normal	57 a 79 pts	Apoyo social suficiente	Población general típica; red funcional adecuada para afrontar estresores.
Déficit de Apoyo	< 57 pts	Apoyo social escaso (< PC 20)	Punto de corte validado en España; aislamiento y alta vulnerabilidad clínica.
Aislamiento Severo	< 38 pts	Colapso de red de apoyo	Desamparo social absoluto; ausencia total de vínculos de auxilio.

PUNTO DE CORTE VALIDADO EN ESPAÑA (MOS-SSS < 57 PUNTOS):

En la validación española (Bellón et al., 1996; De la Revilla), una puntuación total en el MOS-SSS inferior a **57 puntos** (o una puntuación media < 3.00) define el **dintel de apoyo social precario**, asociándose a un riesgo tres veces superior de depresión y somatizaciones.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO TERAPÉUTICO DE ACTIVACIÓN DE RED SOCIAL Y DISPOSITIVOS COMUNITARIOS

PROTOCOLO DE RECONSTRUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL BASADO EN EL MOS-SSS:

- **Paso 1 (Identificación del Perfil por Subescalas):** Desglosar las 4 dimensiones para ubicar la carencia específica:
 - Si falta *Apoyo Instrumental*: Conectar con trabajadora social para tramitar recursos comunitarios (asistente de hogar, teleasistencia).
 - Si falta *Apoyo Emocional*: Focalizar en habilidades asertivas para expresar vulnerabilidad ante personas cercanas.
 - Si falta *Interacción Positiva*: Pautar activación conductual orientada al ocio grupal (talleres, actividades deportivas).
- **Paso 2 (Análisis del Tamaño de la Red Íntima):** Si el ítem 1 es 0 o 1 persona, evitar sobrecargar a ese único informador y diversificar los contactos.
- **Paso 3 (Evaluación en Pacientes Onco-Geriátricos):** Monitorizar el MOS-SSS periódicamente; una caída en el apoyo instrumental predice abandono precoz de tratamientos médicos complejos.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN TRAS DIAGNÓSTICO ONCOLÓGICO Y DUELO VINCULAR

Identificación: Mujer de 56 años, profesora de primaria soltera, diagnosticada de neoplasia de mama en tratamiento quimioterápico adyuvante. Consulta por ataques de angustia, llanto inmotivado y sensación de soledad extrema tras distanciarse de sus compañeras de trabajo ("nadie me llama porque tienen miedo de no saber qué decirme").

Evaluación Psicométrica Inicial MOS-SSS:

- **Puntuación Total MOS-SSS = 34 / 95 puntos (Aislamiento Social Severo; < 10º percentil).**
- *Apoyo Emocional / Informativo* = 12 / 40 pts (Sensación de incomprensión y falta de orientación).
- *Apoyo Instrumental* = 6 / 20 pts (Dificultad para acudir al hospital tras sesiones de quimioterapia).
- *Interacción Social Positiva* = 4 / 15 pts; *Apoyo Afectivo* = 4 / 15 pts; *Red Íntima* = 1 persona (su hermana mayor enferma).

Intervención Psicooncológica: Se integró a la paciente en un grupo de apoyo mutuo para pacientes con cáncer de mama, se conectó con el servicio de voluntariado de acompañamiento hospitalario de la AECC y se realizaron 6 sesiones individuales para desculpabilizar la petición explícita de ayuda a su entorno de amistades.

Reevaluación a los 4 Meses: El MOS-SSS ascendió notablemente a **72 / 95 puntos (Rango Normal / Favorable)**, contando con una red ampliada de 5 personas y normalizando su estado anímico.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

AISLAMIENTO Y RIESGO SUICIDA:

Un MOS-SSS < 30 puntos en un paciente con depresión mayor grave constituye el principal factor psicosocial de consumación suicida por ausencia de rescate vincular ambiental.

DISOCIACIÓN RED ESTRUCTURAL VS. FUNCIONAL:

Un sujeto puede tener 1.000 contactos en redes sociales o familia numerosa pero obtener 25 puntos en el MOS-SSS; nunca asumir apoyo social únicamente por el estado civil o convivencia.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Sherbourne, C. D., & Stewart, A. L. (1991). The MOS Social Support Survey. *Social Science & Medicine*, 32(6), 705-714.
2. Bellón, J. A., Delgado, A., Luna, J. D., & Lardelli, P. (1996). Validez y fiabilidad del cuestionario de apoyo social funcional MOS. *Atención Primaria*, 18(4), 153-163.
3. De la Revilla, L., et al. (1991). Validación de una escala de apoyo social funcional para su uso en la consulta del médico de familia. *Atención Primaria*, 8(9), 688-692.
4. Rodríguez-Marín, J., et al. (1993). Evaluación del apoyo social: Propiedades psicométricas del cuestionario MOS en población española. *Ansiedad y Estrés*, 1(2), 127-142.